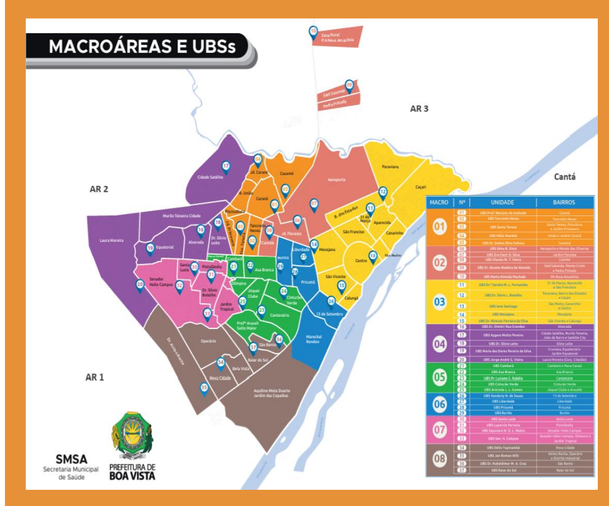
2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

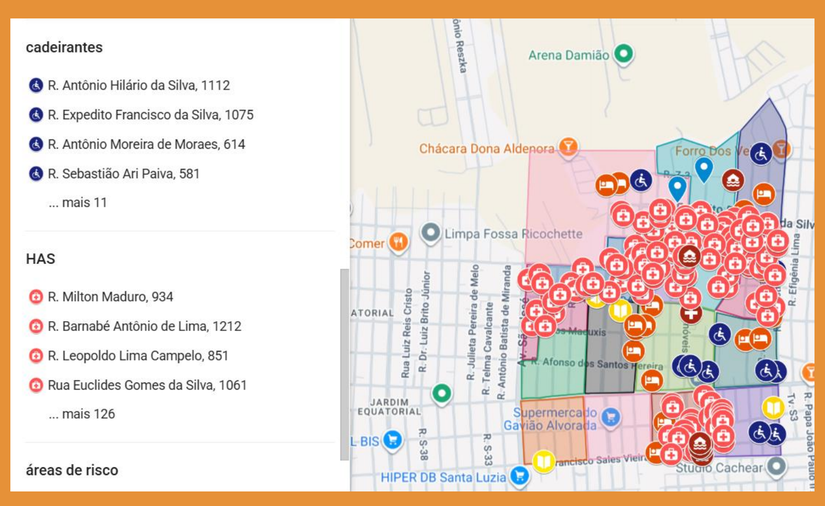
Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

A POPULAÇÃO NO CENTRO DO CUIDADO: GESTÃO DE BASE POPULACIONAL E CADASTRAMENTO NA APS COM APOIO DA PLANIFICAÇÃO EM BOA VISTA/RORAIMA

EDUARDO PADILHA BARROS, Hospital Israelita Albert Einstein
DIANA MARTINS BARBOSA, Hospital Israelita Albert Einstein
LUCILEIA ROSA ELLER, Hospital Israelita Albert Einstein
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista/Roraima





REDEFINIÇÃO DE TERRITÓRIO

A partir do cadastramento e estratificação de risco foi possível redesenhar o território das equipes, considerando as vulnerabilidades de cada território, adotando medidas específicas para cada realidade.

Figura 1: Mapa do Município de Boa Vista, por macroárea.
Figura 2: Mapa da UBS Dimitri Ramos com identificação das subpopulações e vulnerabilidades

Introdução

Boa Vista iniciou o processo de expansão da Atenção Primária em Saúde, com o apoio do Governo Federal por meio do Programa APS do Futuro, ampliando de 60 para 147 equipes, atualmente com 150 equipes. Partindo de uma cobertura de 40% para 95% de cobertura real e 115% de potencial de cobertura.

Objetivos

Relatar o processo de cadastramento populacional e as estratégias de apoio institucional em Boa Vista a partir da Planificação da Atenção à Saúde.

Metodologia

A expansão contou com apoio da equipe do PlanificaSUS do Hospital Israelita Albert Einstein através do PROADISUS, com ferramentas para organização: do território; processos de trabalho e gestão de base populacional. Após delimitação do território, deu-se inicio em abril de 2024 ao cadastramento e atualização cadastral de toda a população do município.

Resultados

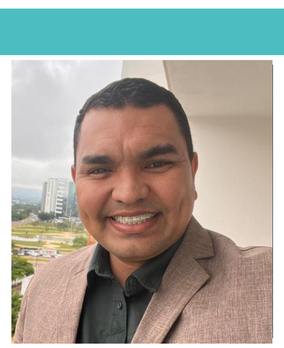
O monitoramento sistemático foi utilizado com meta de cadastramento por UBS. E mensalmente revíamos as estratégias adotadas por cada equipe a partir do Ranking das UBS. O monitoramento permitiu ampliar as estratégias de cadastramento, identificar falhas na atualização cadastral e quantificar a demanda de novos profissionais para as UBS.

Conclusão/Considerações finais

Observamos que em locais onde a população possui alto poder econômico, os ACS tiveram maior dificuldade de acesso e estavam abaixo do esperado para cadastramento. As áreas de maior vulnerabilidade tinham mais acessibilidade aos moradores. A ferramenta de monitoramento proporcional às equipes maior engajamento com foco na produtividade na rotina do cadastramento.

Hospital Israelita Albert Einstein
EDUARDO PADILHA BARROS
CONSULTOR EM SERVIÇO DA APS

E-mail: eduardopbarros92@gmail.com
Contatos: 91 993412478



EINSTEIN Hospital Israelita
PROADI SUS
CONASS
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO